

Sommaire

- I. Concept du stress
- II. Les origines du stress
- III. Les 3 phases d'adaptation
- IV. Reconnaître un trouble de l'adaptation
- V. Les plantes et les cofacteurs du stress

I. CONCEPT DU STRESS

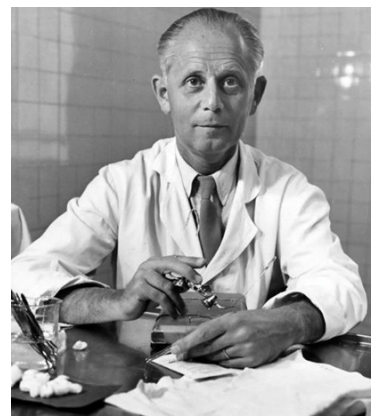
⇒ Stress & anxiété

❖ 1925 : Concept de stress

Le concept de stress et de syndrome général d'adaptation apparaît en 1925, alors qu'Hans Selye étudie la médecine à l'Université de Prague.

Il fut un des premiers chercheurs à s'être intéressé au stress dans la première moitié du XXe siècle.

Il définit le stress comme l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné.



Le changement brutal survenant dans les habitudes d'une personne, jusque-là bien équilibrée, est **susceptible de déclencher un bouleversement dans sa structure psychique et même somatique.**

❖ L'origine de la notion de stress selon le Dr. Hans Selye

Pour le Dr Hans, le stress est une réponse non spécifique du corps à toute demande qui lui est faite.

Il existe une réponse spécifique de l'organisme, qui réagit au froid en produisant de la chaleur, à l'effort physique en sécrétant une hormone qui stimulera l'organisme, etc.

Mais quelle que soit la nature du stimulus, l'organisme répond aussi d'une façon non spécifique, avec des changements biochimiques identiques, destinés à faire face à toute demande accrue imposée au corps humain.

L'organisme répond aux stimuli afin de maintenir ce que les biologistes appellent un état d'équilibre ou homéostasie, c'est-à-dire la constance ou la stabilité des paramètres de l'organisme tels que la température corporelle, le taux de glucose,

... comme une agression de l'organisme par un agent physique, psychique, émotionnel, entraînant un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d'adaptation.

➔ **Pour lui, LE STRESS, C'EST LA VIE, et on l'oublie trop souvent !**

Nous pouvons en faire quelque chose de positif

❖ Selon les neurosciences

Sébastien Bohler, docteur en neurosciences, explique que les menaces ont changé de nature et qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la **base du stress est le fait d'être confronté à l'incertitude** :

"Un homme préhistorique qui est face à un bruit ne sait pas si c'est un prédateur ou autre chose.
C'est là que le stress s'allume.

Aujourd'hui, dans un monde d'incertitudes, on est de nouveau dans un stress qui peut devenir chronique parce qu'on n'arrive pas à le déchiffrer.



Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie moléculaire et fondateur de la revue «Cerveau & Psycho».

❖ Troubles de l'adaptation au stress

L'adaptation est une réaction au stress.

Elle devient un **trouble** lorsqu'elle se manifeste de manière exagérée.

❖ Anxiété

1 personne sur 5 connaîtrait un trouble anxieux dans sa vie.

Ce qui différencie le stress et l'anxiété :

« **LE STRESS**, est une réaction à l'instant T à des événements.

« **L'ANXIÉTÉ**, est une anticipation et qui peut devenir une anticipation pathologique ou trop lourde.
(L'anticipation de la mort au quotidien par exemple).

Ex : Vous êtes en train de ruminer sur : 'Peut-être vais-je mourir dans l'heure qui vient ou dans les deux jours?

⇒ C'est extrêmement lourd, et consomme énormément d'énergie psychique. Donc c'est vraiment une pathologie de l'anticipation."

❖ Selon Dr Frédéric Fanget, médecin psychiatre

« **L'anxiété, c'est une émotion qui est plutôt vécue à l'intérieur de nous.** Donc on est plutôt dans quelque chose qui va se **passer dans la pensée**, dans ce qu'on appelle le **cognitif**.

« **Le stress**, est plutôt **une réaction** et on est bien au niveau **du cerveau émotionnel**.

⇒ « **Lors d'un épisode d'anxiété**, on a cette alarme qui va être déclenchée parce **qu'on a peur de prendre les transports en commun** ou parce **qu'on a peur de partir en voyage** sans avoir tout prévu.

⇒ « **On parle d'intolérance à l'incertitude** qu'on retrouve beaucoup chez **les anxieux**. Les personnes ayant toutes ces anxiétés vont se faire des films catastrophe dans leur tête. **Ça va se passer beaucoup plus sous forme de scénario** »



❖ Selon Dr Guillaume FOND, médecin psychiatre

Il met l'accent sur l'axe microbiote-cerveau comme levier d'adaptabilité : un terrain intestinal équilibré soutient la résilience émotionnelle et psychique.

Le microbiote intestinal (communauté de bactéries, virus, champignons dans l'intestin) agit comme un véritable organe d'interface : il participe à la digestion, à l'absorption, à la régulation immunitaire, et, via l'axe intestin cerveau, exerce une influence directe sur le cerveau. (Guillaume Fond),

⇒ Livre : **Bien manger pour ne plus déprimer : Prendre soin de son intestin pour prendre soin de son cerveau**, Éd. Odile Jacob, 6 avril 2022)

Une perturbation de ce microbiote (déséquilibre, inflammation digestive de bas-niveau) peut fragiliser la régulation émotionnelle et rendre l'organisme plus vulnérable au stress.

Dans son ouvrage, le Dr Fond souligne comment l'alimentation, en modulant le microbiote, peut influencer l'humeur et la santé mentale



❖ Les plusieurs grands types d'anxiété

ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE

Ce sont des gens qui s'inquiètent pour tout, qui ont peur de tout, tout le temps. Il faut compter 5 à 6 % de la population.

L'ANXIÉTÉ SOCIALE

La phobie sociale généralisée, c'est à peu près 5 % de la population. Ce sont des gens qui ont peur du regard des autres, très gênés dans toutes les relations sociales.

LES TROUBLES PANIQUE

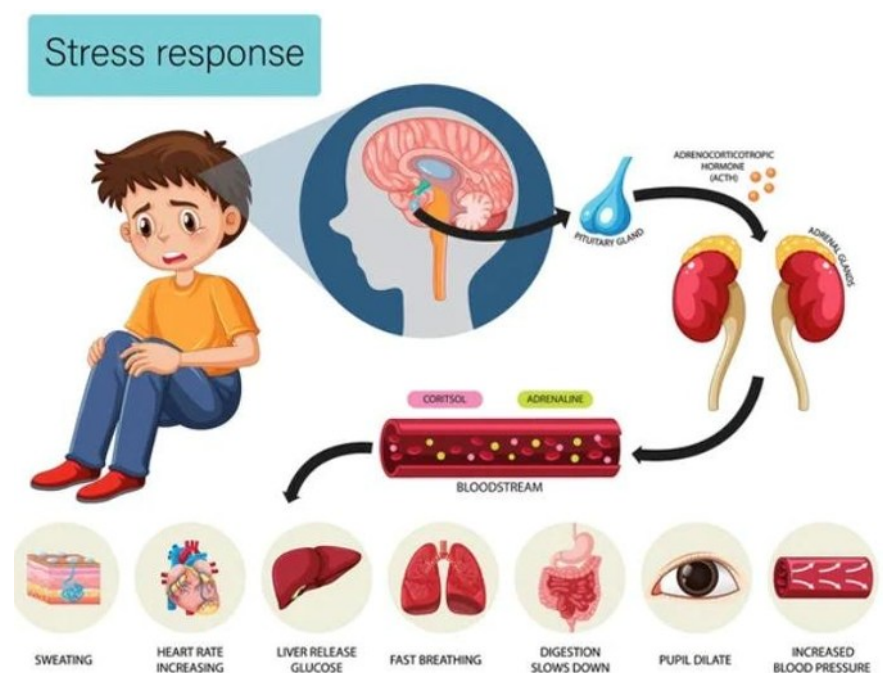
Ils peuvent être seuls ou peuvent être contigus avec des troubles agoraphobiques, avec des gens qui font des grandes crises d'angoisse et qui sont gênés dans leurs déplacements pour faire les choses. autour de 5 % de la population.



❖ Le stress : maladie de notre époque

- **Maladie de notre époque**
- **Evoqué au cours de près de 80 % des consultations.**
- **A l'origine de certaines maladies.**

→ La réaction de stress peut être définie comme l'ensemble des réponses de l'organisme à une sollicitation d'environnement



❖ La réaction de stress normale est physiologique

« Le stress est un ingrédient indispensable de la vie à condition d'être bien dosé »

- **BON STRESS** : réponse positive de l'organisme à une stimulation vécue agréable : **SYNDROME D'ADAPTATION**
- **MAUVAIS STRESS** : celui qui perturbe et rend mal à l'aise, entraîne la souffrance vécue désagréable : **TROUBLE DE L'ADAPTATION**
- **TROP PEU DE STRESS : INACTIVATION**

❖ Les différentes sources de stress

PHYSIQUE : bruit, lumière artificielle, douleur, froid, chaleur, ...

SOCIAL : solitude, éclatement de la famille, environnement, ...

EMOTIONNEL : contrainte, injustice, décès, peur, ...

PROFESSIONNEL : chômage, surmenage, lourdes responsabilités, pressions psychologiques, conflits relationnels,...

Stress lié à l'HYGIENE DE VIE : repas pris rapidement, trop riches en sucres et en graisses, abus de médicaments ou excitants, manque de sommeil, ...

Ce n'est pas l'agent agresseur qui est source de troubles mais la réaction de l'organisme à cet agent



II. LES ORIGINES DU STRESS

⇒ Un mécanisme de défense

❖ Stress : réaction face à un danger

Initialement, c'est une réaction face à un danger. Notre environnement a beaucoup changé, il y a quelques millions d'années nous vivions au milieu de prédateurs et il fallait mettre en place un système de reflexes de réactions rapides face au danger qui nous permet de fuir ou de nous battre.

Au fond, on se plaint beaucoup du stress, des pathologies liées au stress mais il faut considérer que sans le stress nous n'existerions plus en tant qu'espèce nous nous serions fait dévorer par les prédateurs.

Phase problématique c'est quand il devient chronique, ce système d'alarme n'a pas la vocation d'être allumé en permanence : **syndrome général d'adaptation**

Risque, chronique, permanente on développe des mauvaises stratégies pour le gérer :

➔ LE PROBLÈME N'EST PAS LE STRESS MAIS LA GESTION DU STRESS

❖ Etat de fuite

⇒ DÈS QUE LE DANGER EST DÉTECTÉ, L'ORGANISME SE PRÉPARE À DÉTALER

- **Accélération préventive du cœur** et de la respiration pour favoriser l'oxygénation des tissus.
- **Dilatation périphérique des petits vaisseaux ou capillaires**, qui permet au sang de mieux irriguer les organes périphériques comme les muscles.
- **Augmentation du tonus dans les jambes pour mieux courir**, attention dispersée et regard fuyant pour cerner les dangers et les issues possibles.

❖ La lutte

⇒ LE SUJET EN ÉTAT DE COLÈRE SE SENT « GONFLÉ »

- **La focalisation du regard**, qui fixe dans les yeux pour connaître l'intention de son adversaire.
- **Un certain ralentissement du cœur et de la respiration par rapport à la « fuite »**, car il s'agit moins d'un effort maximum que d'une détente ciblée.
- **La tension se déplace des jambes vers le cou et les mâchoires**, pour mordre, et dans les bras et les mains, pour griffer ou taper.
- **La sécrétion d'adrénaline complète le tableau de la colère**, qui tombe aussi vite qu'elle est montée, en fonction de la perception du danger et de l'issue du combat.

❖ L'inhibition

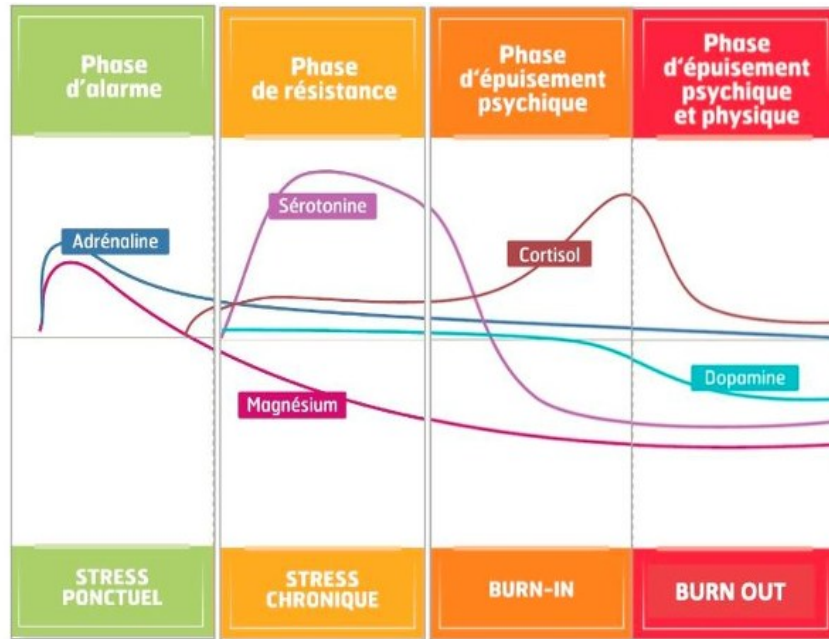
Quand l'animal n'est pas encore repéré, L'INHIBITION LUI PERMET DE SE RENDRE (PRESQUE) IMPERCEPTIBLE

- **Respiration étouffée pour être totalement silencieux**, d'où la sensation d'oppression respiratoire.
- **Constriction des capillaires sanguins pour économiser la chaleur et l'énergie** - d'où la sensation de froid profond, puisqu'il faut désormais « durer », pendant « l'attente en tension », jusqu'à ce que le prédateur parte.
- **Pour économiser l'énergie, le cœur se ralentit, les extrémités se refroidissent**, le teint devient blême et des spasmes peuvent apparaître, car la digestion se bloque.

III. LES 3 PHASES D'ADAPTATION AU STRESS

❖ Les différents phases du stress selon Hans Seyle

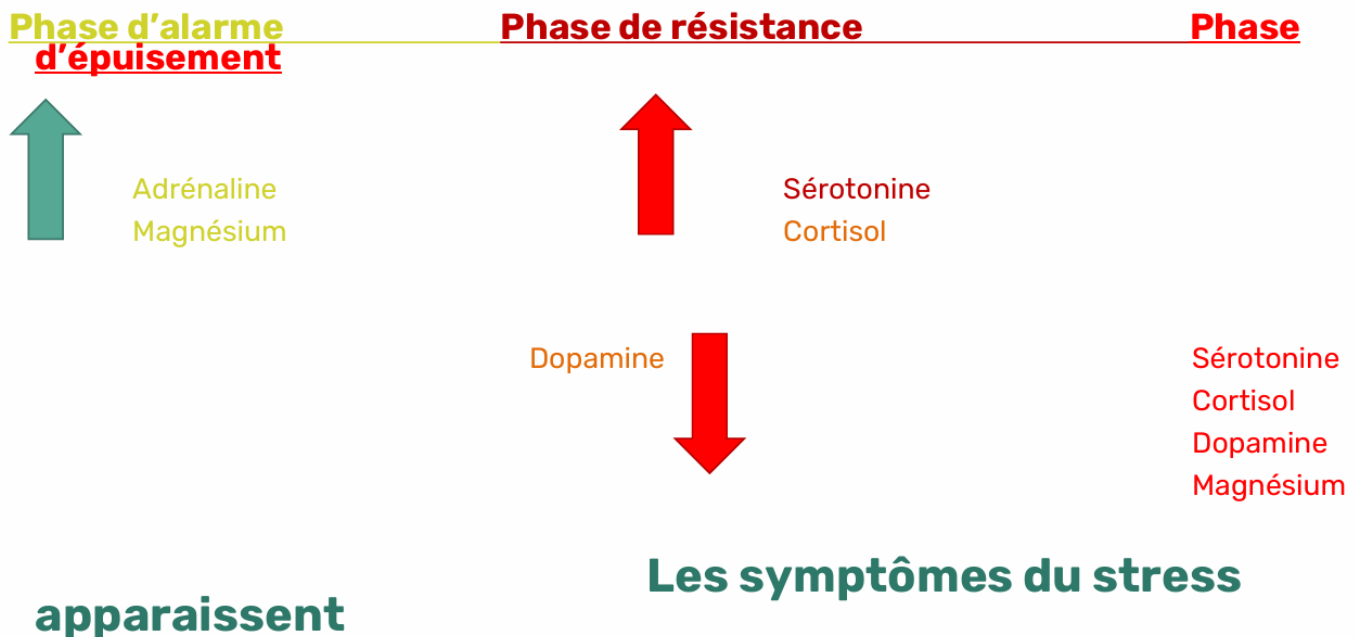
1. La phase d'alarme
Stress ponctuel nécessitant une réponse « rapide » devant une situation inattendue



2. La phase de résistance
Stress chronique avec adaptation de l'organisme pour gérer une situation déplaisante pendant une période prolongée

3. La phase d'épuisement
Stress chronique avec inadaptation de l'organisme par épuisement physique, psychique et émotionnel

❖ Les 3 phases d'adaptation au stress



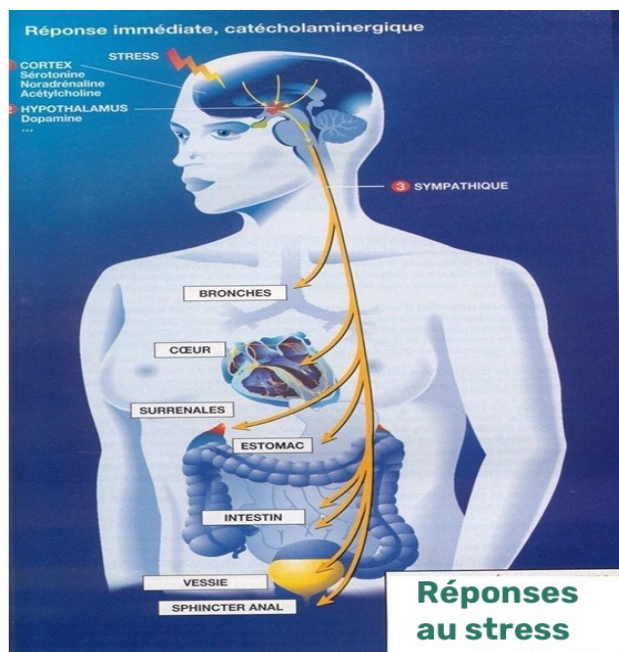
❖ Face au danger : les modifications physiologiques

Augmentation

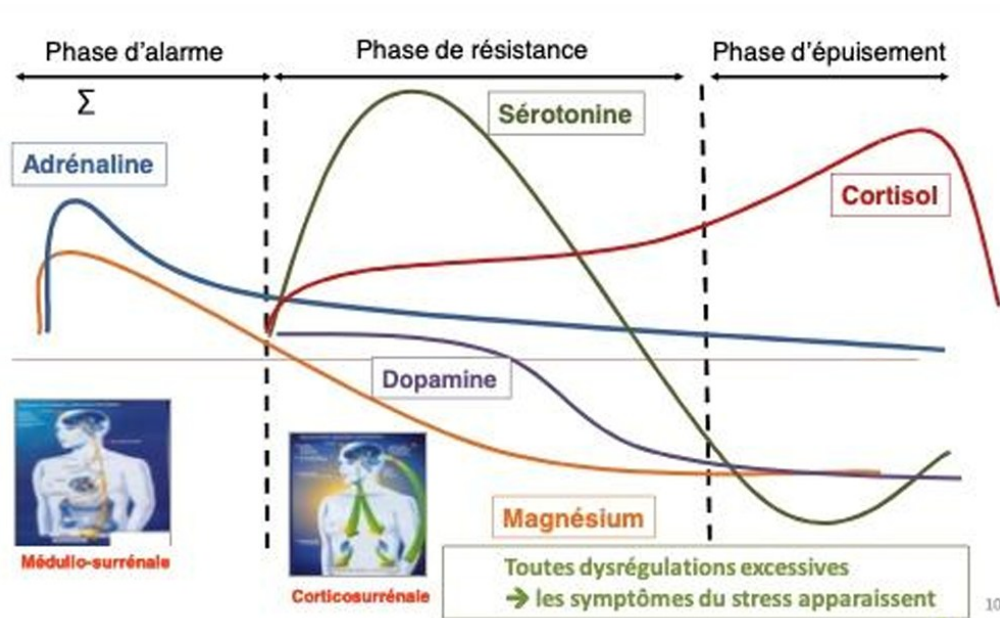
de l'**adrénaline**, répond à un besoin d'énergie
du **cortisol**, régulateur du stress et de l'énergie

Diminution de :

- la **dopamine**, hormone de la motivation, de l'énergie
- de la **sérotonine**, prise de recul et détente



❖ Neurobiologie des 3 phases du syndrome d'adaptation



Médullo-surrénale produit des hormones (catécholamines) adrénaline et noradrénaline

Corticosurrénale produit des hormones (corticostéroïdes) : cortisol (métabolisme, glycémie, réponse inflammatoire, SI), ...

1. Phase d'alarme : réaction instantanée de l'organisme face au stress



Processus déclenché par l'augmentation de certaines hormones par lequel les graisses stockées dans le tissu adipeux sont décomposées en acides gras et en glycérol, qui sont ensuite libérés dans la circulation sanguine pour être utilisés comme source d'énergie

Lipolyse
Glycogénolyse

Le premier mécanisme qui rentre en jeu est la glycolyse, la dégradation des sucres dans le sang, puis intervient la lipolyse et la glycogénolyse.

adrénaline,
noradrénaline

Hormone libérée en réponse à un stress : augmente la fréquence cardiaque, la glycémie et améliore la vigilance

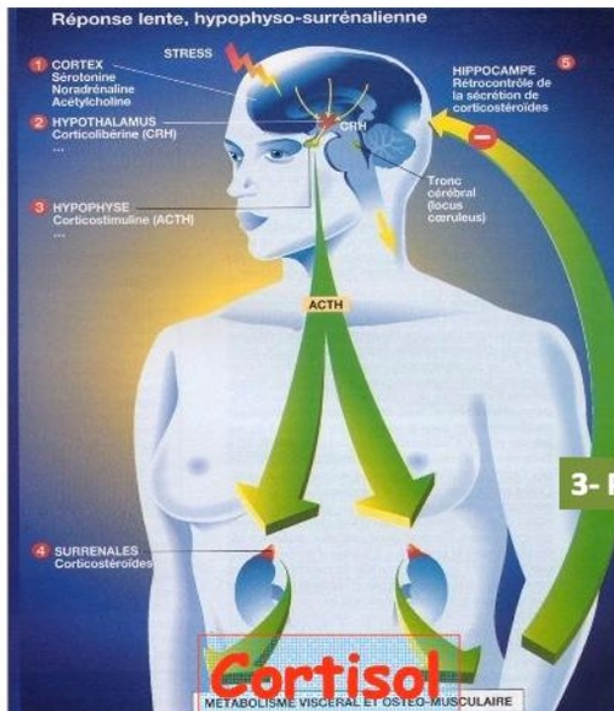
Hormone produite par les glandes surrénales et le SNS en réponse à un stress : augmentant la fréquence cardiaque, la PA et la dilatation des pupilles.

Vasoconstriction
Sécrétion de rénine

La réduction du diamètre des vaisseaux sanguins augmente la PA et le flux sanguin vers les muscles et le cerveau, aidant à préparer le corps à la lutte ou à la fuite. Aide aussi à fournir de l'oxygène et des nutriments essentiels aux tissus qui en ont besoin.

Enzyme produite par les reins. agit sur une protéine dans le sang pour produire une substance appelée angiotensine II, qui peut augmenter la pression sanguine et le volume de sang dans le corps pour protéger contre les effets du stress. En fournissant rapidement de l'oxygène et des nutriments aux tissus

2- Phase de résistance : sous influence répétée ou chronique sur plusieurs jours



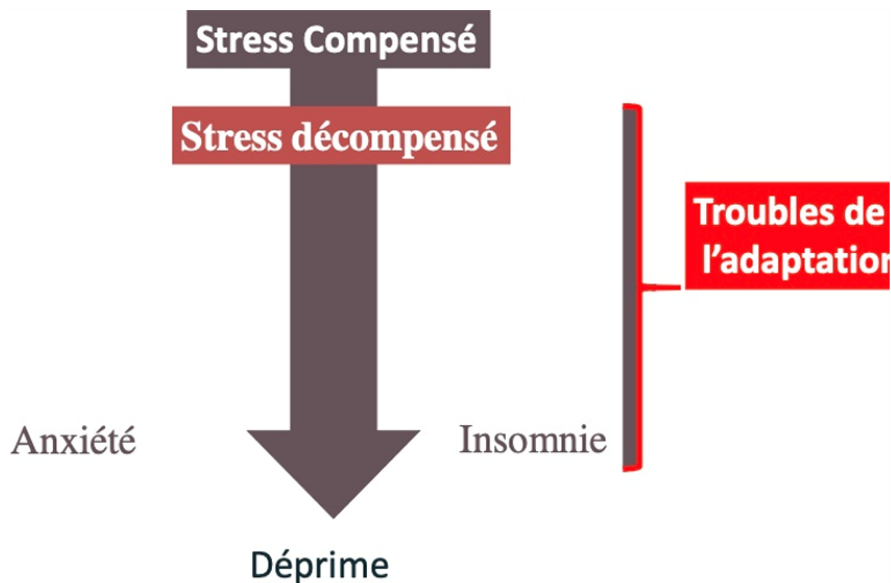
- Lorsque nous sommes confrontés à une situation stressante, notre corps réagit en libérant des hormones du stress : le cortisol et l'adrénaline, pour nous aider à faire face à la situation.
- Cette réponse est déclenchée par une partie de notre cerveau appelée l'hypothalamus, qui envoie un signal à l'hypophyse (glande à la base du cerveau).
- L'hypophyse à son tour sécrète une hormone appelée ACTH, qui stimule les glandes surrénales, situées au-dessus des reins, à libérer du cortisol et de l'adrénaline.

Cette réponse au stress peut être ralentie lorsque le corps est confronté à un stress prolongé ou chronique, comme un travail stressant, une relation difficile ou des problèmes financiers.

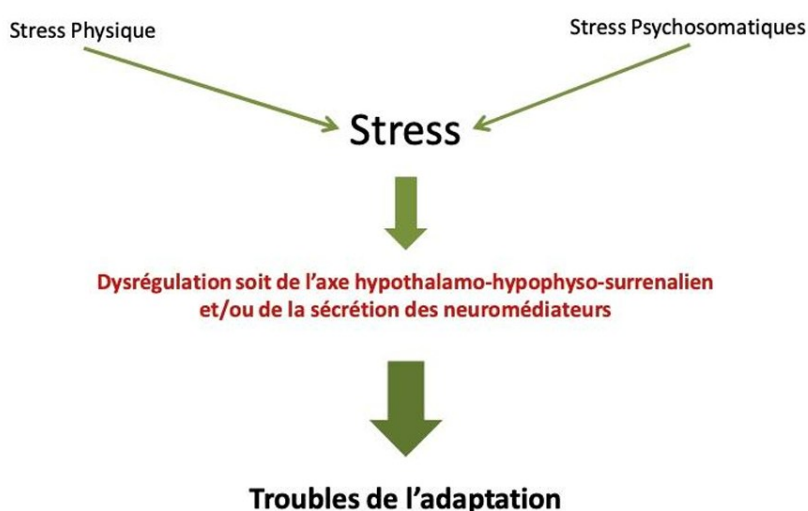
3- Phase d'épuisement

Si la pression dépasse une certaine limite ou durée

❖ Du stress compensé au stress décompensé : troubles de l'adaptation



❖ Les troubles de l'adaptation



❖ Les troubles de l'adaptation : les signes somatiques (sans preuves scientifiques reconnues à ce jour)

PROFIL A

RÉPONSE EXPRIMÉE AGRESSIVE



SECRETION DOMINANTE
d'ADRENALINE

RISQUE PATHOLOGIQUE
CARDIOVASCULAIRE

- Hypertension
- Infarctus

PROFIL B

RÉPONSE ADAPTÉE

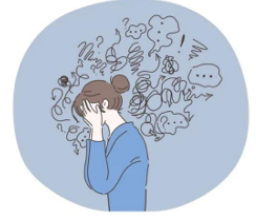
BONNE ANALYSE
mais les personnes de profil A qui
répriment leur réaction ou qui sont en
position de «dominés rejoignent le profil
C



RISQUES MODÉRÉS

PROFIL C

RÉPONSE RÉPRIMÉE



SECRETION DOMINANTE
de CORTISOL

RISQUE PATHOLOGIQUE
BAISSE d'IMMUNITÉ
Infections, ulcères, allergies,
troubles hormonaux, ...

❖ Les troubles de l'adaptation : les signes psychosomatiques

ETAT DE DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE D'EXPRESSION VARIÉE :

Symptômes d'anxiété : peur, appréhension, inquiétude, tension intérieure, ...

Symptômes d'angoisse : fatigue, palpitations, boule dans la gorge, nausées, ...

Symptômes de tension motrice : douleurs musculaires, tressautements musculaires, de paupières, ...

Symptômes de « vigilance » : difficulté de concentration, troubles du sommeil, ...

Colère, agressivité, déprime : perte de plaisir, désir, motivation...

❖ Les conséquences du trouble d'adaptation

Cardiovasculaires

Oppression cage
thoracique, palpitations,
boule dans la gorge, ...



Troubles du sommeil



Neuromusculaire

Douleurs cervicales,
crampes, contractures
+++



Neurovégétative

Spasmophilie,
nervosité +++,
spasmes intestinaux



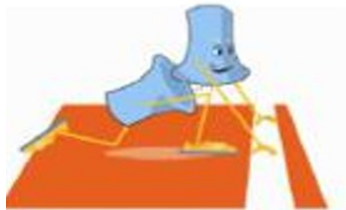
Fatigue
Épuisement,
burn out



❖ Rappel sur les neurotransmetteurs

DOPAMINE

Le STARTER



Bien démarrer la journée, motivation pour se lever le matin

NORADRENALINE

L'ACCELERATEUR



Envie de faire des projets, de les mettre en œuvre

SEROTONINE

LE FREIN



Prise de recul, faire face aux obstacles

❖ Les troubles liés à un déficit en dopamine

BAISSE de CONCENTRATION



DIMINUTION DES PERFORMANCES INTELLECTUELLES

- Difficultés de concentration
- Perte de mémoire

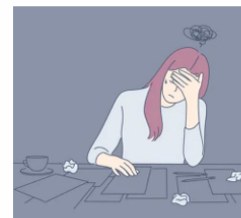
MANQUE de MOTIVATION



TROUBLES

- Fatigue matinale
- Difficulté à se lever

FATIGUE PERSISTANTE



FAIBLESSES & DIFFICULTÉS à PRENDRE des DÉCISIONS

- Introversion
- Repli sur soi

❖ Les troubles liés à un déficit en sérotonine

ANXIÉTÉ AGITÉE



TROUBLES de L'HUMEUR MODÉRÉE

Irritabilité, sautes d'humeur, difficulté d'endormissement, impatience, vulnérabilité au stress, ralentissement

DÉPRIME « HOSTILE »



TROUBLES

- Agressivité
- Impulsivité
- Perte du désir

TROUBLE « ADDICTIF »



- Tabac
- Alcool
- Compulsions alimentaires
- Hyperactivité

IV . RECONNAITRE UN TROUBLE DE L'ADAPTATION

⇒ **Stressé, anxieux, déprimé, Burn out**

❖ Se poser les questions suivantes

Mon consultant est-il :

- STRESSÉ ?
- ANXIEUX ?
- DEPRIMÉ ?
- EN BURN-OUT ?

❖ Observer



FRONT PLISSÉ



Impression de TRISTESSE



REGARD vers le bas

❖ Regarder



ANOREXIE
Manque de dopamine



BOULIMIE, compulsions
sucrées
Manque de sérotonine



GROS MANGEUR, sédentaire
Terrain acide

4

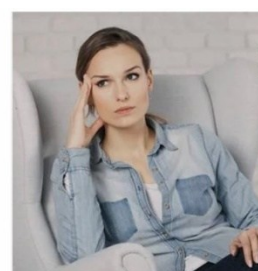
❖ Ecouter



VOLUBILE



IMPATIENT



MUTISME

❖ Les différents questionnaires

HAD L'échelle HAD est un instrument permettant de dépister les troubles anxieux et dépressifs. Elle comporte 14 items cotés de 0 à 3. Sept questions se rapportent à l'anxiété (total A) et sept autres à la dimension dépressive (total D).

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-11/outil__echelle_had.pdf

DNS Dopamine/Noradrénaline/Sérotonine

Questionnaire fonctionnel de l'humeur. L'humeur, les comportements, les pensées, les émotions sont largement influencées par les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs

<https://www.iedm.asso.fr/le-dns-dopamine-noradrenaline-serotonine-francais>

QMS Questionnaire médical de Santé permettant de dresser un véritable état des lieux de l'état de santé, en dépistant certains déséquilibres ou déficits en micronutriments.

<https://www.qms-iedm.fr/>

❖ Restez vigilant

Selon ANAES, repérer le consultant à risque dépressif au moyen de deux questions :

« **Au cours des derniers mois :**

- 1- Vous êtes-vous senti abattu, déprimé ou désespéré ?
- 2- Avez-vous ressenti peu d'intérêt ou de plaisir à faire quoi que ce soit ? »

Réponse positives aux deux questions : consultant à risque

⇒ N'hésitez pas à l'orienter vers un professionnel de la santé

ANAES : Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé

❖ Définitions : anxiété, déprime, burn out,

ANXIETE

Trouble mental courant caractérisé par une préoccupation excessive, une appréhension et une peur.

DEPRIME

Affection caractérisée par une tristesse persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir, une baisse d'énergie, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et d'autres symptômes émotionnels et physiques. Elle peut entraîner des conséquences significatives sur la vie quotidienne, les relations interpersonnelles et la capacité de fonctionner normalement.

BURN OUT

Situation d'épuisement émotionnel, de dépersonnalisation et de réduction de l'accomplissement personnel qui apparait chez les individus impliqués professionnellement auprès d'autrui - Selon l'OMS : « un sentiment intense de fatigue, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail »

❖ Les manifestations de l'anxiété

- Sentiment d'insécurité face à un péril de nature indéterminée
- Elle n'est plus liée à des événements de la vie
- Elle survient sans raison
- Elle peut devenir permanente
- Elle perd sa fonction d'aide aux changements de la vie et elle favorise davantage la répétition ou la limitation des comportements que les possibilités d'adaptation du sujet

▶ Symptômes d'appréhension

(peur, appréhension, inquiétude, tension intérieure...)

▶ Symptômes d'angoisse

(fatigue, palpitations, boule dans la gorge, nausées...)

▶ Symptômes de tension motrice

(douleurs musculaires, tressautements musculaires, battements de paupières ...)

▶ Symptômes de « vigilance »

(difficulté de concentration, troubles du sommeil ...)

❖ Déprime ou dépression

Les symptômes de la dépression peuvent varier d'une personne à l'autre :

Humeur dépressive : Une tristesse persistante, une sensation de vide ou d'irritabilité.

Perte d'énergie et fatigue : Une sensation de fatigue constante, même après le repos.

Troubles du sommeil : Insomnie (difficulté à s'endormir, réveils fréquents) ou hypersomnie
Changements d'appétit : Une perte d'appétit (perte de poids), ou une augmentation (prise de poids).

Difficultés de concentration et de prise de décision : mal à se concentrer, des décisions simples.

Sentiments de culpabilité ou de dévalorisation : Une tendance à se critiquer constamment.

Perte d'intérêt pour les activités : ou de plaisir pour les activités quotidiennes.

Troubles du comportement : l'isolement social, le retrait des relations et des activités sociales.

❖ Définition du Burn out

TOUTES LES DÉFINITIONS ACTUELLEMENT CONVERGENT SUR UN POINT :

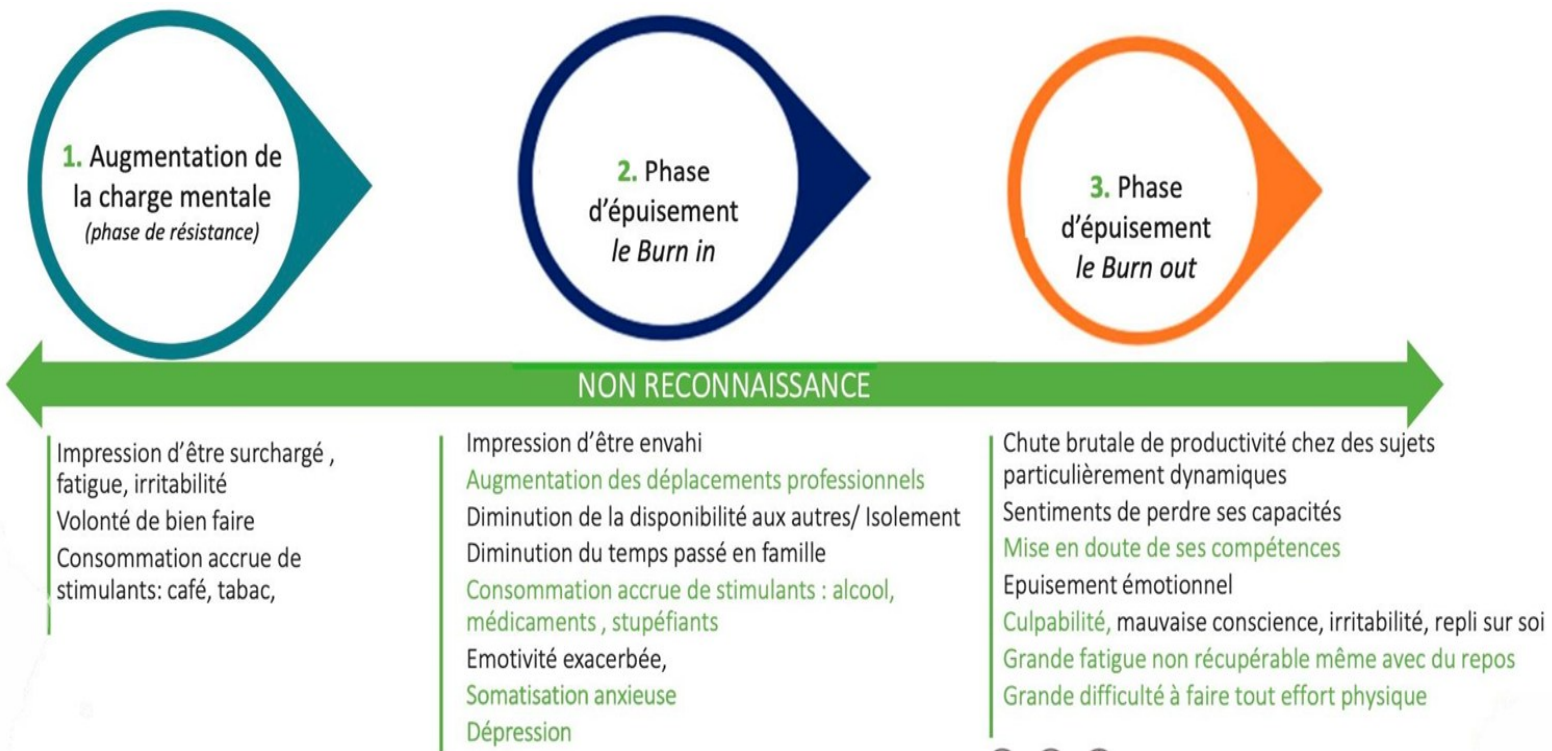
- **ÉTAT D'ÉPUISEMENT**
- **À LA FOIS ÉMOTIONNEL, PHYSIQUE ET PSYCHIQUE**

RESSENTI FACE À :

DES SITUATIONS DE VIE ÉMOTIONNELLEMENT EXIGEANTES, AVEC INCAPACITÉ DE RÉCUPÉRER SUR DE COURTES DURÉES MÊME AVEC DU REPOS

INFORMATION: fait intéressant le concept de Burn out semble se décliner en dehors du travail, comme par exemple le Burn out parental.

❖ Le déprimé en burn out : de la souffrance psychique au syndrome d'épuisement



❖ 3 questions par l'affirmative : le burn out est possible

1. Êtes-vous fatigué lorsque vous pensez à votre travail ?
2. Au travail, avez-vous tendance à mettre de plus en plus de distance entre vous et vos consultants ?
3. Doutez-vous de votre utilité au travail et du sens de votre travail ?

❖ Questionnaire du Burn-out

BURN OUT

Questionnaire CBI (Copenhagen Burnout Inventory)

Ce questionnaire explore trois dimensions du burn out :

- L'épuisement personnel
- L'épuisement professionnel
- L'épuisement relationnel

V. LES PLANTES

⇒ Et les cofacteurs du stress

Rhodiola

Rhodiola rosea L.



FAMILLE :

Crassulacées

PARTIES UTILISÉES :

Rhizome et racines

PRINCIPAUX COMPOSANTS :

Dérivés du phényléthanol :

salidroside (rhodioloside), p-tyrosol

Phénylpropanoïdes : rosavine, rosine, rosarine

Flavonoïdes : rodionine, rodiosine, acétylrodialgine, tricine

Monoterpènes : rosiridol, rosaridine

Tanins : catéchine, proanthocyanidines

Triterpènes (stérols) : daucostérol, bétasitostérol

Acide phénolique : Acide chlorogénique, acide hydroxycinnamique, acide gallique

Composants volatils (0,05% d'HE) : géraniol

PROPRIÉTÉS

PHARMACOLOGIQUES :

Amélioration des capacités physiques et intellectuelles

Activité antidépressive et neuroprotectrice

Activité anxiolytique

Maintien du cortisol à des doses physiologiques

Action immunomodulante

PRINCIPALES INDICATION

Stress

Anxiété

Dépression légère à modérée

Comportement addictifs



Par mesure de précaution, l'emploi chez les femmes enceintes, allaitantes et chez l'enfant de moins de 6 ans est déconseillé

Contre-indication : troubles bipolaires

Effets secondaires : Si dosage mal adapté risque d'excitation

FEVE DES MARAIS

Vicia faba



Famille : des Fabacées

Partie utilisée

en phytothérapie : la graine

Vicia faba connue sous le nom de fève des marais est cultivée pour ses graines nutritives et ses gousses qui sont consommées. La fève est cultivée par l'homme depuis le néolithique (7000 ans avant JC), elle est originaire des régions méditerranéennes du Proche-Orient.

Composés chimiques de la graine

- Protéines
- L-Dopa
- Carbidopa (C-dopa) : inhibiteur de la dopa décarboxylase (DDC) au niveau péréphérique
- flavonoïdes : monomères de flavanol (gallo catéchine, épigallocatechine and catéchine), proanthocyanidines, flavonols, flavanonols, isoflavones (génistéine and daidzéine) and flavanones
- Composés phénoliques dont acides phénoliques (acide caféique, acide férulique, acide p-coumarique et acide synaptique)
- Amidon, Fibres, Choline, Lécithine, Minéraux

Précautions d'emploi : Ne pas utiliser en cas de favisme

Griffonia

Griffonia simplicifolia



FAMILLE :

Fabacées

PARTIES UTILISÉES :

Graines

PRINCIPAUX COMPOSANTS :

Dérivés indoliques : 5-hydroxytryptophane, acide aspartique, acide indolacétique

Alcaloïdes : griffonine (lithospermoside)

Lectines,

Lipides,

Glucides

PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Activité sérotoninergique

Action antidépressive

Action sédatrice et hypnotique

Action antimigraleuse

Action sur la douleur liée à la fibromyalgie

PRINCIPALES INDICATIONS :

Dépression sérotoninergique

Troubles de l'endormissement

Traitement de fond de la migraine

Douleurs liées à la fibromyalgie

IRRITABILITÉ, COLÈRE FRUSTRATION

BESOIN DE SUCRE surtout en fin d'après midi

PROBLÈME D'ENDORMISSEMENT
(impossible de débrancher le cerveau)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes, et aux personnes sous traitement antidépresseur. Déconseillé aux enfants trisomiques (rares cas de convulsions lors de traitements prolongés avec du 5-HTP).

EFFETS SECONDAIRES : Possibilité de légers troubles gastro-intestinaux (nausées notamment), généralement temporaires.

CONTRE-INDICATIONS : Tumeurs carcinoïdes de l'intestin grêle.

Interactions médicamenteuses : Tous les antidépresseurs et antagonistes modérateurs du niveau de sérotonine. Toute association de griffonia avec des antidépresseurs nécessite un avis médical.

ELEUTHEROCOQUE



Botanique :

- *Eleutherococcus senticosus*
- Araliacées
- Racine

Principaux composants :

- **Polysaccharides**
 - Eleuthéranes (A à G)
- **Composés phénoliques**
 - Dérivés de phénols :
 - Syringine (éleuthéroside B)
 - Acides phénolique (acide chlorogénique, acide caféique)
 - Lignanes
 - Sésamine (éleuthéroside B4)
 - Syringarésinol-diglucoside (éleuthéroside D)
 - Liriodendrine (éleuthéroside E)
- **Terpénoïdes**
 - Saponines
 - Eleuthérosides I à M
 - Senticosides A à F (glycosides de l'acide oléanolique)
 - Stérols
 - Eleuthérosides A (Daucostérol)

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS :

- Modulateur de la sécrétion du cortisol lors de stress (propriétés « adaptogènes »)
- Augmentation des performances physiques
- Activité neuroprotectrice
- Activité hypoglycémiant
- Activité immunostimulante et anti virale
- Activités cardioprotectrice (Antiarythmique , régulateur de la TA...)

Précautions d'emploi

- Chez les hypertendus sévères
- Chez les personnes atteintes de maladies auto-immunes (si donné au long cours)
- Chez la femme enceinte et allaitante par manque de données toxicologiques

GINSENG



↳ Botanique :

- *Panax ginseng* CA meyer
- Araliacées
- Racine fraîche

↳ Principaux composants :

- Ginsénosides
- Peptidoglycanes (panaxanes),
- Polysaccharides



↳ Principales propriétés :

- Stimulant intellectuel & physique
- Immunomodulant
- Anxiolytique & analgésique (modulateur de l'axe corticosurrénalien, des neuromédiateurs (Dopamine, Noradrénaline, GABA ..))
- Régulateur du métabolisme glucidique

GINKGO



↳ Botanique :

- *Ginkgo biloba*
- Ginkgoacées
- Feuilles

↳ Principaux composants :

- Terpènes, lactones diterpéniques : ginkgolides A, B
- Substances flavonoidiques:
 - ginkgoflavonols, biflavones, flavonols libres, proanthocyanidine



↳ Principales propriétés :

- Protecteur vasculaire cérébral
- Anti-œdémateux, anti-ischémique, oxygénateur des tissus, antifibrosique
- Anti-plaquettaire, anti-allergique (Anti PAF aceter)
- Antioxydant et protecteur cellulaire
- Neuroprotecteur
- Modulation des taux de noradrénaline, des glucocorticoïdes, de l'ACTH et du CRF.

VALERIANE

↳ Botanique :

- *Valeriana officinalis*
- Valérianacée
- La racine



↳ Principaux composants :

- Iridoides : valépotriates
- Acides sesquiterpéniques
- Flavonoïdes

↳ Principales propriétés :

- Anxiété - angoisse ++
- Somatisation s neuromusculaires
- Troubles du sommeil

- ▶ Douleurs musculaires
- ▶ Crampes musculaires
- ▶ Algies vertébrales et articulaires fugaces et erratiques

Contre-indication : femme enceinte, allaitante, enfant de moins de 12 ans

PASSIFLORE



ANXIÉTÉ – AGITATION++

↳ Principaux composants :

- Flavonoïdes
- Alcaloïdes
- Polysaccharides
- Hydroxycoumarine
- Tanins catéchiques
- Maltol

↳ Somatisation digestive

- Reflux Oesophago-Gastrique
- Nausées, vomissements
- **Spasmes intestinaux**
- Colopathie Fonctionnelles

↳ Somatisation Cardiovasculaire

- Tachycardie
- HTA

↳ Somatisation Neuromusculaire

- Contracture musculaire

CASSIS



Botanique :

- *Ribes nigrum*
- Saxifragacées
- Feuilles

Principaux composants :

- Flavonoïdes
- Proanthocyanes
- Tanins

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS :

- Modulateur de la sécrétion de la cortico-surrénale
- À dose physiologique, le cortisol stimule les défenses contre l'infection, anti allergique
- Anti-inflammatoire
- Chondroprotecteur
- Diurétique

TILLEUL



Botanique :

- *Tilia vulgaris*
- Malvaceae
- Inflorescence

Principaux composants :

- Flavonoïdes
- Polysaccharides
- Tanins (proanthocyanidols)
- HE

Anxiété

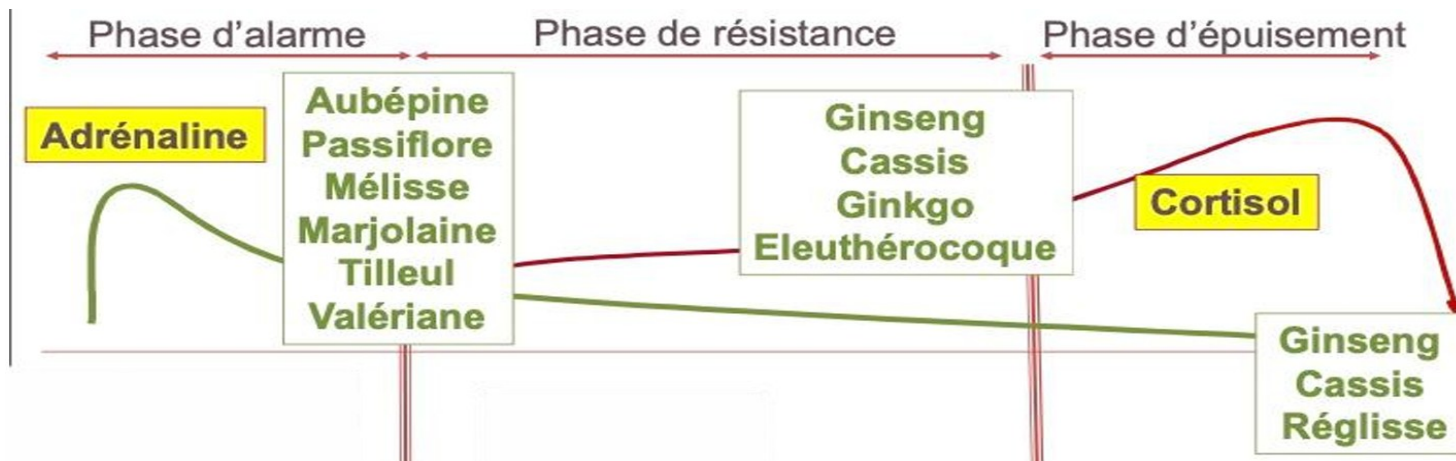
Troubles du sommeil

Hypotenseur

PLANTE DE LA :

- Femme enceinte, allaitante
- Enfant < 12 ans

❖ Les plantes : 3 phases du stress



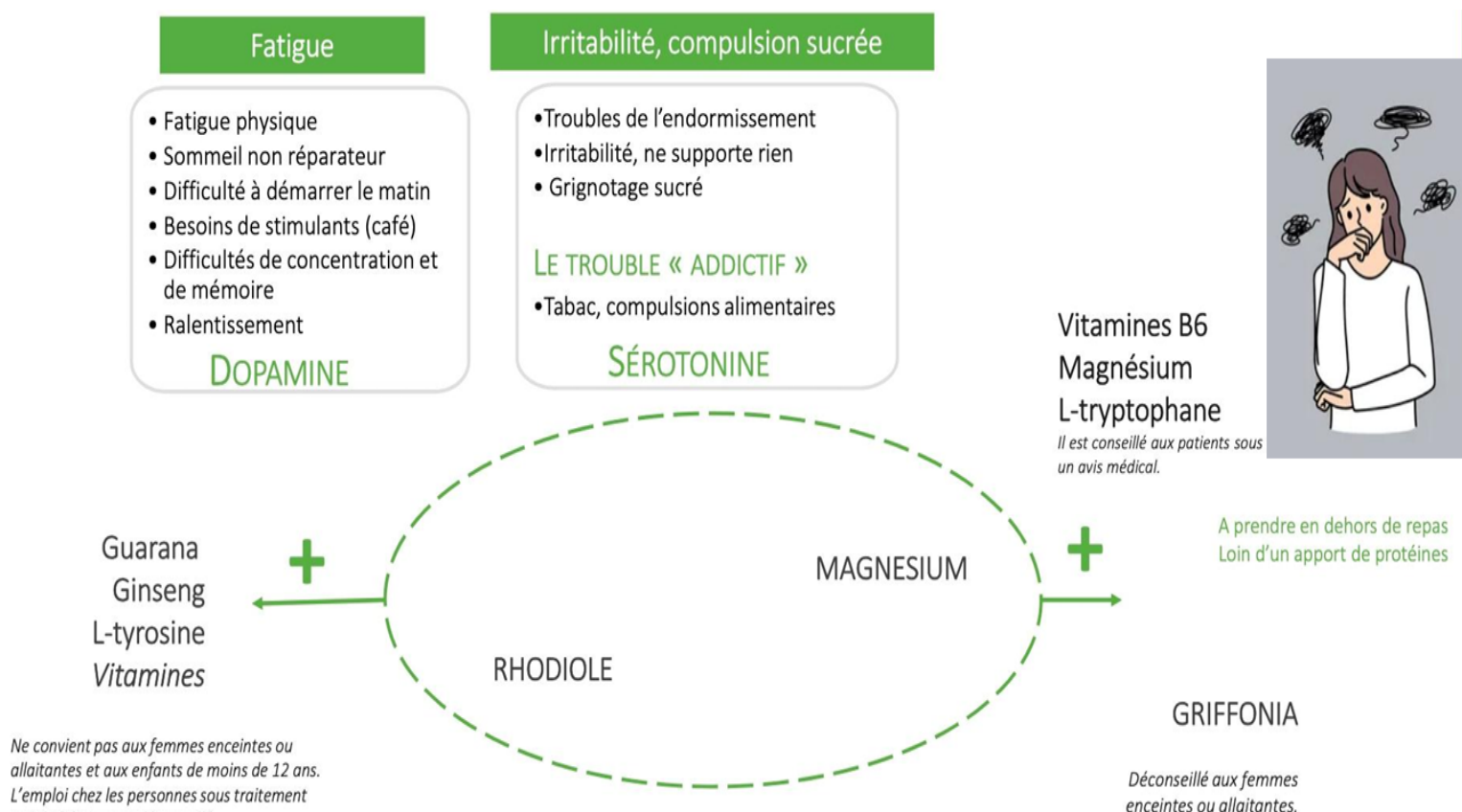
❖ Des vertus adaptées

Plantes « adaptogènes »
▪ Cassis
▪ Eleuthérocoque
▪ Ginseng
▪ Ginkgo
▪ Réglisse

Plantes anxiolytiques
▪ Aubépine
▪ Marjolaine
▪ Mélisse
▪ Passiflore
▪ Valériane

Plantes sédatives
▪ Aubépine
▪ Passiflore
▪ Valériane
▪ Tilleul

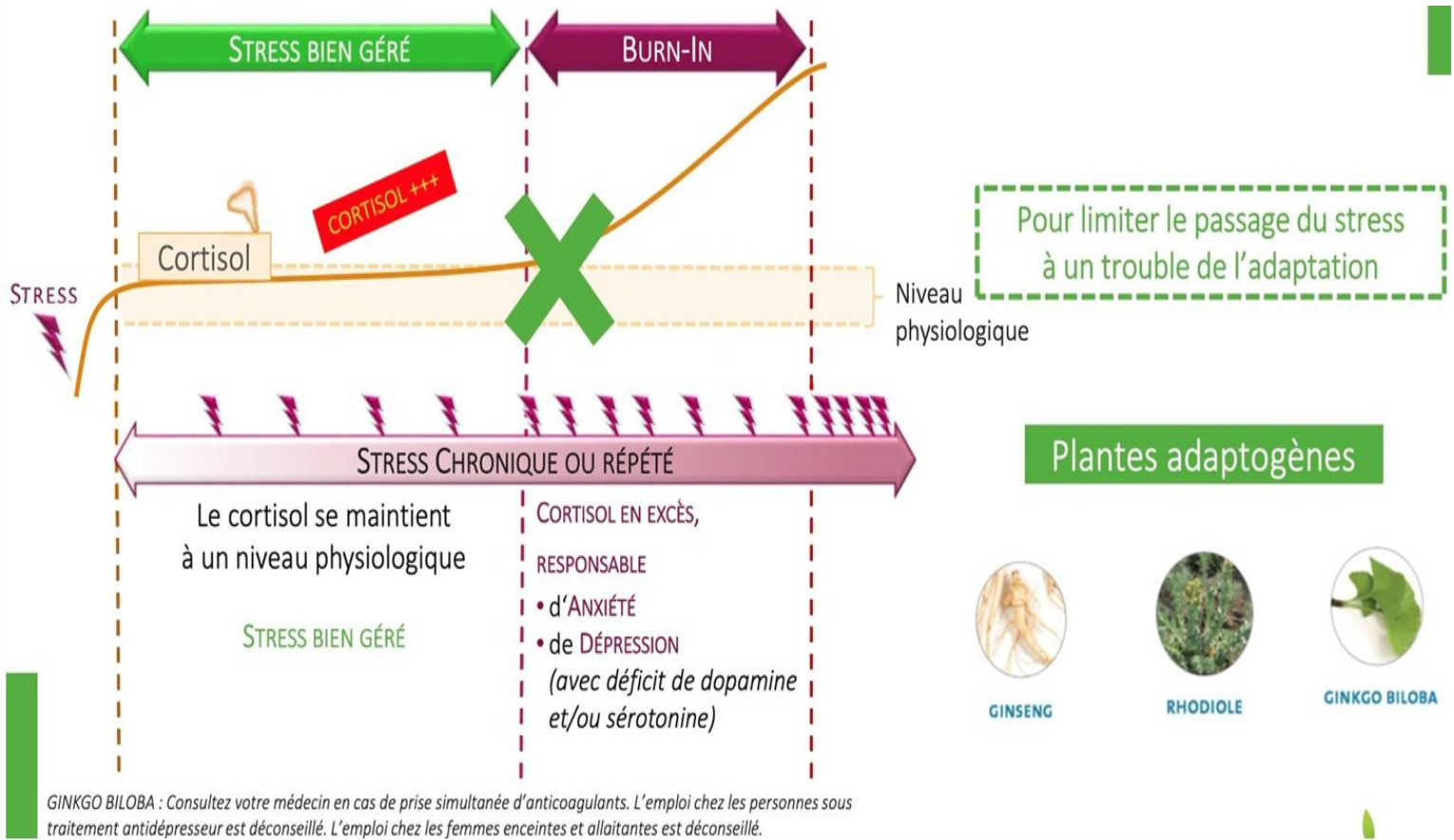
❖ Prise en charge du stress



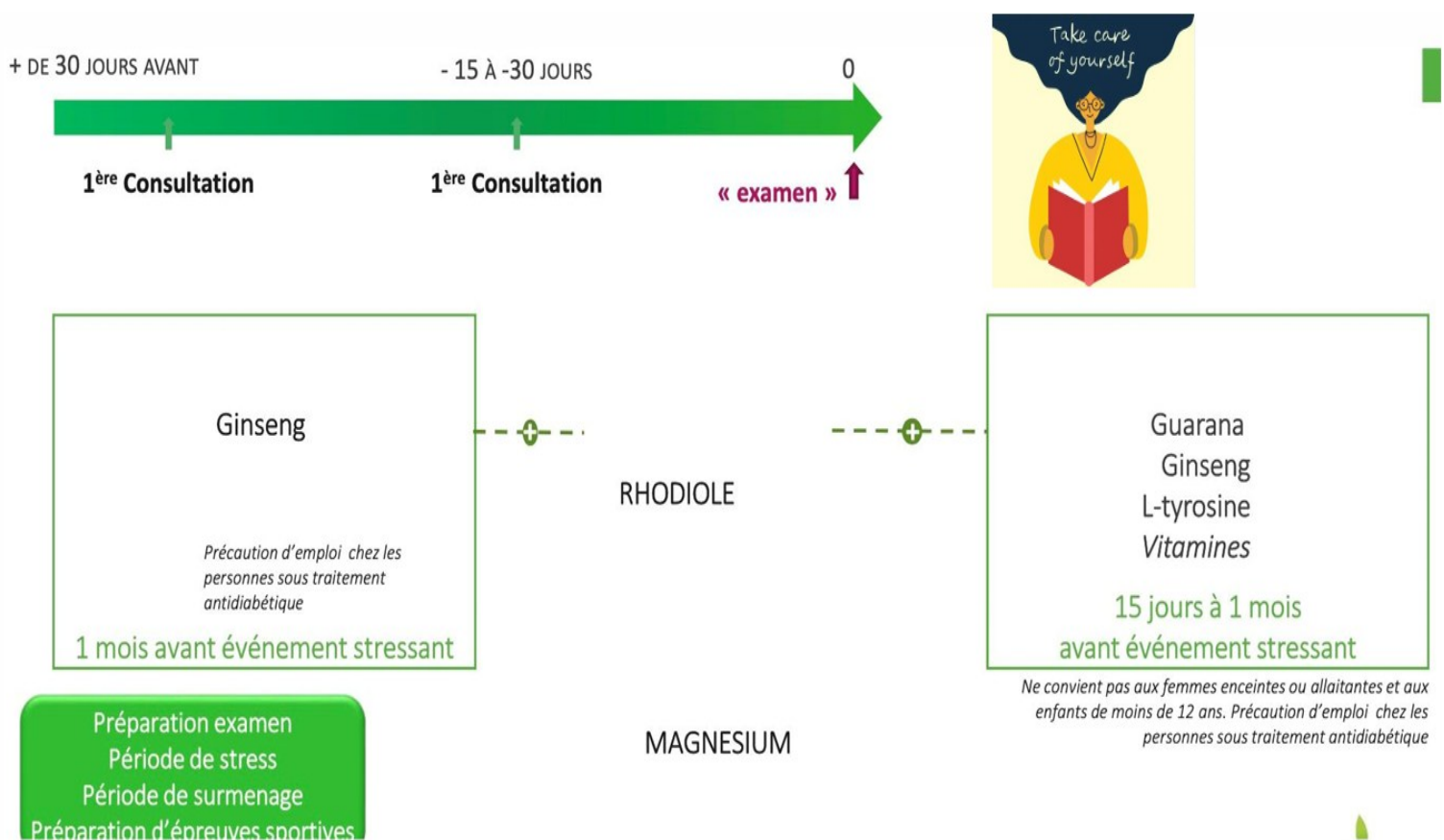
GRIFFONIA

Déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes.

❖ La gestion du stress chronique et du cortisol



❖ Préparation à une période de stress



❖ L'individualisation de la prise en charge en fonction de la somatisation

ATTENTE ANXIEUSE

Inquiétude, sans objet défini,
appréhension, tension intérieure



Aubépine

+ Aubépine

SOMATISATION CARDIOVASCULAIRE

Oppression cage thoracique,
palpitations, tachycardie

Aubépine

+ Aubépine

TROUBLES DU SOMMEIL

Difficultés d'endormissement, Éveils nocturnes,
sommeil non réparateur

Eschscholtzia - Valériane

Eschscholtzia/Valériane

Rhodiola

SOMATISATION DIGESTIVE

Hautes : gastrites, nausées, RGO
Basses : TFI, colite spasmodique

Mélisse - Passiflore

Haute : + Mélisse Basse : + Passiflore



SOMATISATION NEUROMUSCULAIRE

Tension, crampes, contractures musculaires +++,
tensions nerveuses

Valériane

+ Valériane

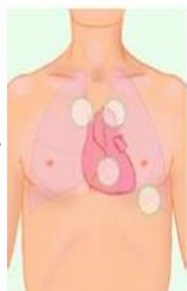


Valériane : L'emploi chez les enfants de moins de 12 ans est déconseillé.

❖ Plantes selon la somatisation

Cardiovasculaires

Oppression cage
thoracique, palpitations,
boule dans la gorge, ...



➔ Aubépine,
passiflore

Neurovégétative

Spasmophilie,
nervosité +++,
spasmes intestinaux



➔ Mélisse, passiflore

Troubles du sommeil

Passiflore, valériane,
tilleul



Neuromusculaire

Douleurs cervicales,
crampes, contractures +++

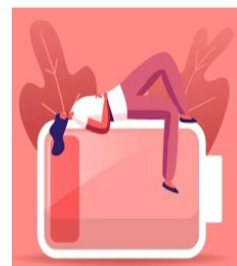


➔ Passiflore, valériane

Fatigue

Épuisement, burn out

➔ Cassis, éleuthérocoque,
gingko, ginseng, réglisse



❖ Les déficits fonctionnels en micronutriments participants aux troubles de l'adaptation

LE MAGNÉSIUM

Le magnésium soutient l'équilibre nerveux en facilitant l'action du GABA, neurotransmetteur clé du calme intérieur.

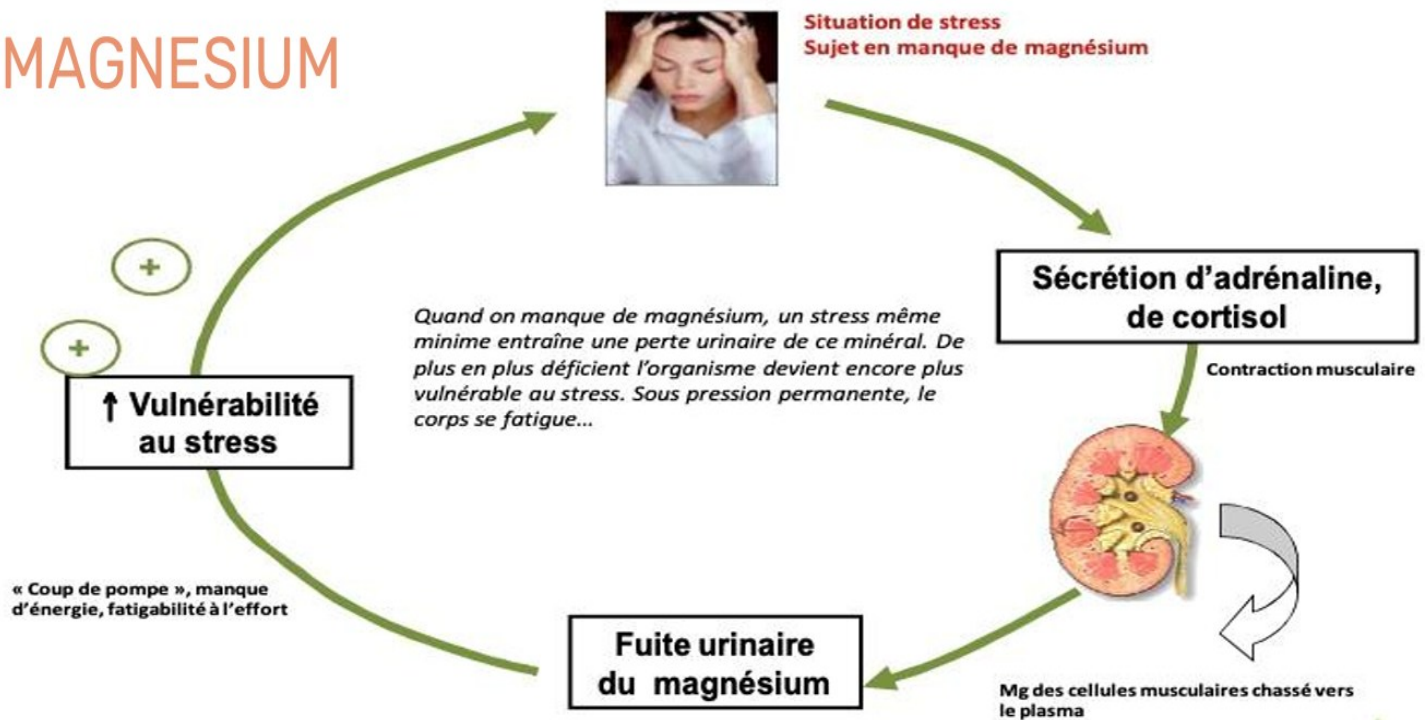
Sous stress, le cortisol augmente son élimination urinaire, ce qui réduit les réserves cellulaires.

Un niveau suffisant de magnésium favorise une réponse émotionnelle plus stable, une meilleure détente musculaire et une énergie cellulaire plus régulière.

Sources : Pickering G., Nutritional Neuroscience, 2020 ; de Baaij J. et al., Physiological Reviews, 2015.

❖ Déficit en magnésium

LE MAGNÉSIUM



❖ Pourquoi suis-je fatiguée, irritable, sujette aux crampes et je dors mal ?

- 97 % du magnésium se trouve dans vos cellules (pas dans le sang)
- Une simple prise de sang ne détecte pas toujours la carence réelle
- On estime que 75 % des Français sont en déficit fonctionnel
- Le stress, le sport, le sucre, l'alcool, les médicaments consomment votre magnésium

❖ A quoi sert-il vraiment ?

- Plus de 300 réactions enzymatiques en dépendent
 - Régule le système nerveux, musculaire, hormonal et cellulaire
 - Intervient dans : relaxation musculaire, production d'énergie, sommeil réparateur, rythme cardiaque
- ⇒ Sans magnésium, le corps reste en tension permanente, même la nuit.

❖ Pourquoi vous pouvez être carencée... même si vous mangez bien ?

- Seul 3 à 15 % du magnésium est assimilé selon la forme
 - L'intestin peut être perméable ou saturé
 - Le stress fait fuir le magnésium par les urines
 - Les carences en vitamines D et B6 aggravent la fuite cellulaire
- ⇒ Il faut la bonne forme, au bon moment, avec les bons cofacteurs.

❖ Quelles formes privilégier ?

BISGLYCINATE : bien assimilé, doux pour - l'intestin = anxiété, hypersensibilité

MALATE : énergie mitochondriale (vitalité cellulaire) = fatigue, jambes sans repos

TAURATE* : cœur, rythme = soutien cardio

OXYDE/MARIN/CHLORURE : mal absorbés = à éviter si terrain fragile

BISGLYCINATE + MALATE : duo gagnant pour tensions et fatigue.

(*) Le taurate (ou taurinate) de magnésium est une forme de magnésium liée à la taurine

❖ Quand et comment le prendre ?

- Le soir, après dîner ou 30 min avant le coucher
 - Avec eau tiède + vitamines B6 (P-5-P) et D
 - Dose adulte : 400 à 800 mg/j selon les besoins
- ⇒ Le magnésium ne s'accumule pas : il faut le renouveler chaque jour.

❖ À retenir pour vos clients

- ✓ **CRAMPES NOCTURNES ?** Peut-être un manque de magnésium
 - ✓ **TROUBLE DU SOMMEIL ?** Le cerveau a besoin de magnésium pour ralentir
 - ✓ **FATIGUE AU RÉVEIL MALGRÉ 8 H ?** Pensez au magnésium malate
 - ✓ **TENSION MENTALE CONSTANTE ?** Le magnésium est votre bouton pause
- ⇒ Il donne le signal aux enzymes pour lancer la production d'énergie cellulaire

❖ Quand penser au magnésium ?

- ✓ **Crampes (souvent la nuit)**, contractures, tressautements.
- ✓ **Fatigue milieu de journée**, « cerveau brumeux », récupération lente après effort.
- ✓ **Anxiété, irritabilité**, maux de tête, sommeil léger & réveils nocturnes.
- ✓ **Variations tension/rythme (terrain)**, syndrome des jambes sans repos.

❖ Pourquoi la biologie peut tromper

LE MAGNESIUM

- ✓ Environ 97 % du magnésium est intracellulaire : la magnésémie peut rester « normale ».
- ✓ L'assimilation digestive varie selon la forme (ordre de grandeur 3–15 %).
- ✓ Stress, sport, sucre/alcool et certains médicaments augmentent les pertes urinaires

❖ Pourquoi sommes-nous souvent en déficit fonctionnel

- ✓ Appauvrissement des sols et aliments modernes : densité minérale moindre.
- ✓ Eaux très filtrées = moins minéralisées (selon sources locales).
- ✓ Apports alimentaires irréguliers + stress chronique = besoins accrus.

❖ Bien choisir la forme

- ✓ À privilégier : **bisglycinate/glycinate** (système nerveux, crampes, sommeil).
- ✓ **Malate** (énergie mitochondriale, récupération), **taurate** (rythme/cœur), **L-tréonate** (cognition).
- ✓ À éviter si intestin sensible : formes faiblement absorbées (oxyde...) pouvant irriter.

Objectif = tolérance + assimilation, pas le « mg élément » seul.

❖ Synergies essentielles (B6, D)

- ✓ **Vitamine B6 (P-5-P)** : facilite l'entrée et l'utilisation cellulaire du magnésium.
 - ✓ **Vitamine D** : ses enzymes d'activation utilisent du magnésium comme cofacteur.
- ⇒ Sans statut magnésique correct, la réponse à la D peut être atténuée.

❖ Quand et comment le prendre

- ✓ **Moment** : le soir (30–60 min avant coucher) pour le sommeil et les crampes ; ou fractionné 2 prises/jour si doses élevées ou intestin sensible.
- ✓ **Ordre de grandeur adulte** : 300–600 mg/j de magnésium élément (selon forme/poids/terrain).
- ✓ **Augmenter progressivement** ; viser l'effet clinique sans inconfort digestif.

❖ Tolérance & précautions

- ✓ **Effet secondaire principal** : selles molles/diarrhée = réduire / changer de forme.
- ✓ **Insuffisance rénale** : avis médical impératif (risque d'accumulation).
- ✓ **Interactions possibles (certaines antibiothérapies, biphosphonates...)** : espacer les prises.

Le corps élimine naturellement l'excédent de magnésium quand les reins fonctionnent bien, ce qui assure une bonne sécurité d'usage.

❖ Messages clés à retenir

- ✓ **Le magnésium ne « booste » pas** : il recharge et permet la détente active.
- ✓ **Bisglycinate (apaisement) + malate (énergie)** : duo fréquent en pratique.
- ✓ **Effet attendu en quelques jours/semaines** : sommeil plus profond, moins de crampes, énergie plus stable.

❖ Les formes de magnésium et leurs spécificités physiologiques

Forme	Transporteur	Atouts physiologiques	Points clés pour le stress	Terrain privilégié
Bisglycinate	Magnésium + 2 glycine (chélate stable)	Entrée digestive douce, excellente biodisponibilité, tolérance optimale	Soutien nerveux profond via la glycine, équilibre émotionnel	Terrain nerveux, hypersensibilité, sommeil
Malate	Magnésium + acide malique	Soutien du cycle de Krebs, énergie cellulaire régulière	Aide la récupération physique, confort musculaire	Fatigue physique, rythme exigeant
Citrate	Magnésium + acide citrique	Effet alcalinisant, bonne assimilation, aide digestive	Confort digestif en période de stress, régulation acido-basique	Terrain inflammatoire, digestion sensible
Taurate	Magnésium + taurine	Soutien du rythme cardiaque, apaisement nerveux	Modulation du stress, régulation du système nerveux autonome	Anxiété avec palpitations, charge mentale
Thréonate	Magnésium + acide L-thréonique	Passage facilité vers le cerveau, plasticité synaptique	Soutien de la clarté mentale et de la mémoire sous stress	Fatigue mentale, cognition
Pidolate	Magnésium + acide pidolique	Bonne p <i>↓</i> ration cellulaire	Soutien nerveux et hydratation cellulaire	Terrain émotionnel instable

❖ Utilisation physiologique du magnésium

Forme intégrée	Impact physiologique
Bisglycinate	Soutien du calme intérieur, détente profonde
Malate	Production énergétique, récupération physique
Taurate	Harmonie du rythme cardiaque, apaisement nerveux
Citrate	Soutien du terrain acido-basique, digestion légère
Thréonate	Confort cognitif, concentration, mémoire

❖ Le magnésium : choix adapté

Terrain	Formes les plus pertinentes
Nerveux, hypersensibilité	Bisglycinate • Taurate
Terrain inflammatoire	Citrate • Bisglycinate
Fatigue physique	Malate
Anxiété avec palpitations	Taurate
Fatigue mentale	Thréonate

❖ Magnésiums : panorama de certains laboratoires et des formes disponibles

points

Laboratoire	Produit	Forme	Mg élémentaire (moyenne)	Points clés
Le Stum	Magnétione	Bisglycinate	≈110 mg / 2 gélules	Assimilation élevée, digestion stable
Herbolistique	Magnésium Bisglycinate	Bisglycinate	≈150 mg / gélule	Profil nerveux, confort digestif
Therascience	Physiomance Magnésium B6+	Carbonate + Glycérophosphate	≈150 mg / comprimé	Formulation équilibrée, terrain réactif
COPMED	Magnésium Sublingual	Marin + Citrate	≈100 mg / comprimé	Absorption rapide, usage pratique
La Royale	Magnésium Impérial	Glycérophosphate	≈80–120 mg / dose	Très bonne tolérance digestive
LPEV	Magnésium Synergie (version bisglycinate)	Bisglycinate	≈120 mg / dose	Bonne assimilation, formule épurée
*PiLeJe	Astemag	Citrate + levure enrichie	300 mg / stick	Biodisponibilité élevée, format poudre
Nutrixeal	Bisglycinate Albion®	Bisglycinate	≈320 mg / 4 gélules	Forme chélatée premium
*Nutrixeal	UltraMag	Bisglycinate + B6	≈320 mg / 4 gélules	Soutien nerveux + musculaire

(*) Sans taurine

❖ Les déficits fonctionnels en micronutriments participants aux troubles de l'adaptation

LE FER

1) Le fer est impliqué dans de nombreuses fonctions biologiques :

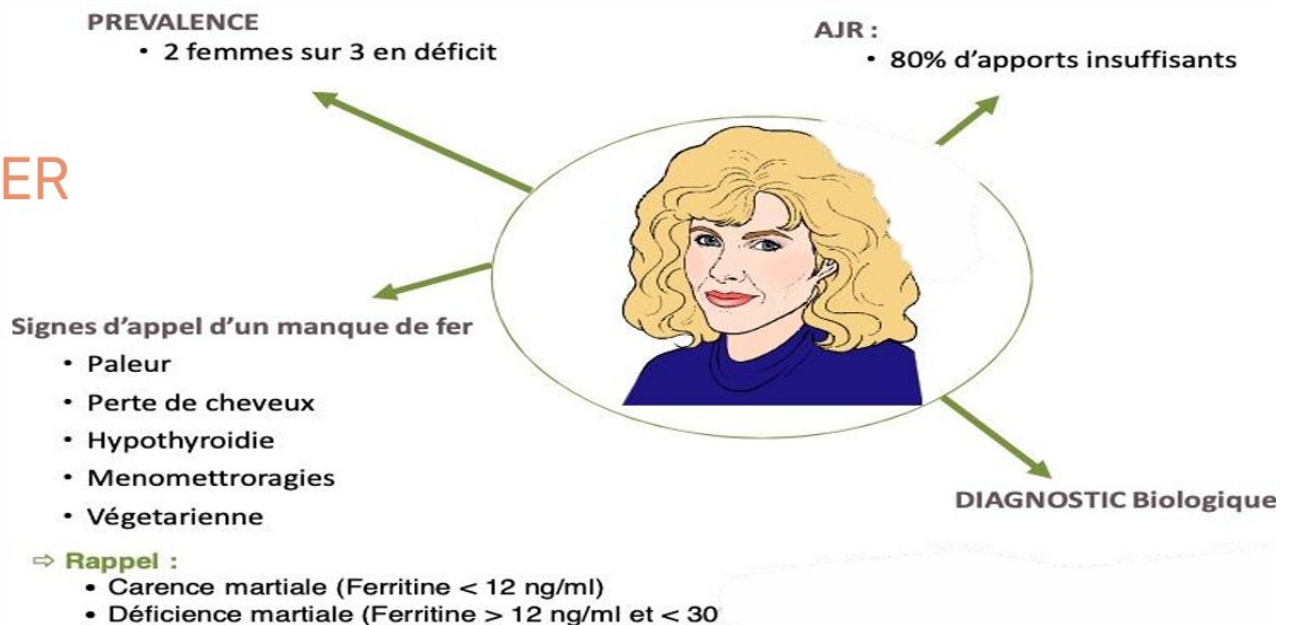
- Transport de l'oxygène
- Synthèse des neuromédiateurs
- Métabolisme des hormones thyroïdiennes
- Immunité

2) Un déficit en fer peut entraîner :

- ⇒ Asthénie avec réduction des performances physiques
- ⇒ Moindre résistance aux infections
- ⇒ **Diminution des performances intellectuelles et scolaires**
- ⇒ **Troubles de l'humeur**
- ⇒ Hypothyroïdie fonctionnelle

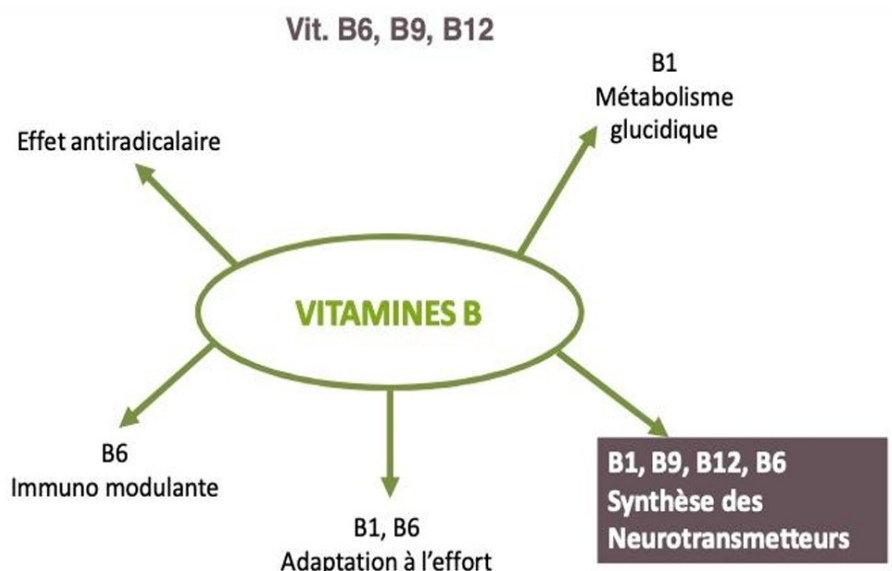
❖ Déficit en fer

LE FER



❖ Déficits en vitamines B

LES VITAMINES B



❖ Sans oublier les déficits en omégas 3

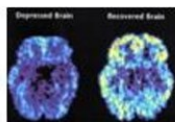
LES OMEGAS 3



- **Effets cardio-vasculaire et métabolique**
 - ➔ Réduction du risque coronarien
 - ➔ Réduction des facteurs de risque (TG, TAV..)



- **Effets sur l'inflammation**
 - ➔ Arthrites
 - ➔ MICI
 - ➔ Inflammation aigue



- **Effets neuropsychiatriques**
 - ➔ Les troubles de l'humeur chez l'adulte « jeune »
 - ➔ Les dépressions saisonnières
 - ➔ Les troubles de l'humeur chez l'enfant
 - ➔ Les troubles du comportement chez l'enfant
 - ➔ La potentialisation des psychotropes

❖ Les quatre grandes étapes de la synthèse des neurotransmetteurs et leurs cofacteurs

FONCTION	COFACTEURS
Hydroxylation	Fer ou Cuivre, B 3
Décarboxylation	Zn, Mg, B2, B6
Stockage vésiculaire	Mg
Méthylation	B6, B9, B12

HYDROXYLATION : Première étape qui active la molécule de départ.

Besoin de Fer ou Cuivre et de vitamine B3.

DÉCARBOXYLATION : Transformation essentielle pour produire dopamine, sérotonine, GABA.

Besoin de Zinc, Magnésium, vitamine B2 et vitamine B6.

STOCKAGE VÉSICULAIRE : Mise en réserve du neurotransmetteur dans les vésicules neuronales. **Besoin de Magnésium.**

MÉTHYLATION : Étape finale de régulation pour stabiliser l'humeur et l'énergie. **Besoin de B6, B9, B12.**

❖ Sans oublier les recommandations de base

Une bonne santé mentale, émotionnelle et psychologique se gagne tous les jours par une hygiène de vie organisée autour de bonnes habitudes de vie.

- Une activité physique régulière hebdomadaire et répétée d'une durée minimum de 20 à 40 mn
- Une durée de sommeil récupérateur adaptée à notre rythme de vie
- Une alimentation tenant compte du choix et de la variété des aliments, du moment dans la journée, de la mastication, des quantités et des moments de jeûne (accepter de ressentir la faim)
- Des temps de pause « sans rien rien faire », juste être
- Des moments de respirations en conscience
- Des plages de créativité dans un domaine qui nous nourrit : musique, dessin, sculpture, écriture, ..
- Et bien sûr une bonne hydratation !

CAS PRATIQUE : CONSULTATION NATUROPATHIE

FEMME (SANS ENFANT) -35 ANS- ASSISTANTE DE DIRECTION (RÉGION PARISIENNE)

MOTIF DE CONSULTATION = règles abondantes, fatigue physique et moral, acné

Gynécologie : pas de contraception

Reins/vessie : mycoses (suite aux rapports)

Transit : constipation

Maux de tête

ORL : acouphènes

Sommeil : très variable

Humeur : parfois anxiété

tabac/alcool : sans

aucun traitement en cours

AP : marche

Vie privée : en cours de séparation

RECOMMANDATIONS

• **COMPLEMENTS ALIMENTAIRES**

⇒ **MACERAT BOURGEONS de FIGUIER** : 10 gouttes le matin à jeun

⇒ **OMEGAS 3 EPA** : 3 gél au dîner

⇒ **MAGNESIUM MARIN** : 2 gél le matin

⇒ **HUILE d'ONAGRE** : 2 gél matin et soir du 14 au 28 e j du cycle

⇒ **FER + FLORADIX**

• **CONSEILS DE VIE**

⇒ **ANALYSES** : FERRITINE + VIT D + ZINC

⇒ **RDV PSYCHOSOMATIQUE**

RESULTATS AU 2ND RDV «Je vais bien mieux » : 😊

ENERGIE : pas fatiguée

CHEVEUX : tombent un peu moins (assez conséquent)

HALEINE : macérat de figuier (haleine mieux) grâce aux légumes

PEAU : plus de boutons un peu sous les joues

MORAL : en dent de scie

SPORT : a repris et arrêter depuis 1 semaine

DIGESTION : bonne

TRANSIT : bien

SPM : moins abondantes mais toujours douloureuses

MYCOSES : démangeaisons persistent mais moins !

SOMMEIL : un peu saccadé

CAS PRATIQUE : CONSULTATION NATUROPATHIE

FEMME 2 ENFANTS - 60 ANS- TRAITEUR GASTRONOMIE & AUTEUR (SUD DE LA FRANCE)

MOTIF DE COSNULTATION = se sent lourde, cellulite, nervosité (sa mère a été diagnostiquée »autiste »)

Tension : basse

Dentaires : aphtes / gencives sensibles

Gynécologie : pas de THS / bouffées de chaleur

Transit : tendance constipation

Circulation : cellulite

Cheveux : perte / **Ongles** : striés

Humeur : parfois tristesse

AP : pas assez d'énergie

ORL : gorge sensible

tabac/alcool : oui

RECOMMANDATIONS

- **COMPLEMENTS ALIMENTAIRES**

- ⇒ **OMEGAS 3 & FER**

- ⇒ **GINSENG/ ELEUTHEROCOQUE**

- ⇒ **VIT D SPRAY**

- ⇒ **RODHIOLA**

- **CONSEILS DE VIE**

- ⇒ **RDV ostéopathe**

- ⇒ **RDV pour une psychothérapie**

- ⇒ **ANALYSES**

- ⇒ **COURS YOGA**

RESULTATS AU 2ND RDV Se sent vraiment mieux, envie de faire, de vivre !

RDV OSTEOPATHE : ça a fait du bien + se sent bien

RDV PSYCHOTHERAPIE : a fait 2 séances par visio a envie de continuer

ENERGIE : se sent mieux dans son corps

MORAL : meilleur elle est partie plusieurs fois en vacances

DIGESTION : OK

TRANSIT : SBM

BOUFFEES de CHALEUR : finis !

CELLULITE : pareil

PEAU : un peu moins sèche (visage) / **CHEVEUX** : plus de volume / **ONGLES** : mieux

CAS PRATIQUE : CONSULTATION NATUROPATHIE

FEMME (mariée sans enfant) - 32 ANS- VETERINAIRE/OSTEOPATHE EQUIN /JOCKEY (RP)

MOTIF DE CONSULTATION = acné chronique

Gynécologie : pas de pilule depuis 6 mois

Cycle 32 jours / sans SPM

REINS/Vessie : cystites

Digestion & transit : ok (nausées transport)

PEAU : acné (haut du dos /menton & tempes)

DOULEURS : spondylartryte ankylosante

AP. : renforcement musculaire au quotidien

Information : travaille dans un milieu masculin ++

OBSERVATION

- ⇒ **Le terrain hyperandrogénique** (soit un niveau élevé d'hormones mâles, appelées androgènes dans le corps) déclenché par l'utilisation répétée de ses muscles par sa profession **génère une augmentation de testostérone qui favorise un déséquilibre hormonal (acné).**
- ⇒ **Il est démontré qu'une augmentation de la testostérone peut favoriser la production accrue de sébum par les glandes sébacées de la peau.**
- ⇒ **Cet excès de sébum peut obstruer les pores, créant un environnement propice à la prolifération de bactéries responsables de l'acné.**

RECOMMANDATIONS

• COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

⇒ **MAGNESIUM & FER**

⇒ **COMPLEXE** : Les vitamines C et E contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif

⇒ **MEASTRAGALE** (immunostimulante) /**ORTIE RACINE** (régulateur hormonal)/**REGLISSE**

• CONSEILS DE VIE

- ⇒ **Travailler sur le côté YIN (féminin)**, acceptation du féminin, essayer dans la mesure du possible par l'intention dans un premier temps de réduire la surutilisation de la testostérone.

RESULTATS AU 2ND RDV

Elle a vu une amélioration en prenant les compléments

En période professionnelle intense, elle n'a pu ralentir mais elle a compris !

ENERGIE : toujours bonne

PEAU : mieux au début avec CA sauf si alcool/sucre/produits laitiers

STRESS : mieux géré mais en a fait plus !

BOUTONS : on replit à l'arrêt des compléments alimentaires

Références

- Article "Stress and Its Management: Historical Overview" publié dans le Journal of Human Stress en 1980, Oxford-Duham Richardson and Montgomery 2005
- Etude Adelaïde placebo contre double aveugle chez les enfants TDAH, Australie, Sinn and Byrant, J. Behav. Ped. 2007 Nemets et Bal. American journal of psychiatry 2007
- Cohen, S., Kessler, R. C., & Gordon, L. U. (Eds.). (1997). Measuring stress: A guide for health and social scientists. Oxford University Press.
- McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the brain. *Physiological reviews*, 87(3), 873-904.
- Lupien, S. J., McEwen, B. S., Gunnar, M. R., & Heim, C. (2009). Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition. *Nature reviews neuroscience*, 10(6), 434-445.
- Selye, H. (1956). The stress of life. New York: McGraw-Hill.
- Kalia, M. (2002). Assessing the economic impact of stress—The modern day hidden epidemic. *Metabolism*, 51(6), 49-53.
- Chrousos, G. P. (2009). Stress and disorders of the stress system. *Nature reviews endocrinology*, 5(7), 374-381.
- McEwen, B. S. (2008). Central effects of stress hormones in health and disease: Understanding the protective and damaging effects of stress and stress mediators. *European journal of pharmacology*, 583(2-3), 174-185.
- Légeron, P. (Ed.). (2009). Le stress au travail: Diagnostic et prévention. Elsevier Masson.
- Melchior, M., Caspi, A., Milne, B. J., Danese, A., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2007). Work stress precipitates depression and anxiety in young, working women and men. *Psychological medicine*, 37(8), 1119-1129.
- Marchand, A., Juster, R. P., Durand, P., & Lupien, S. J. (2016). Burnout symptom sub-types and cortisol profiles: What's burning most? *Psychoneuroendocrinology*, 66, 144-145.
- Grebot, E., Andlauer, O., Azzi, R., & Villa, P. (2017). La prévention du stress et des risques psychosociaux: de la théorie à la pratique. *Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé*, 19(1).
- Ganem, V., et al. (2018). Stress et burnout chez les internes en médecine générale en France : étude EMOJI. *Archives des maladies professionnelles et de l'environnement*, 79(3), 360.
- Légeron, P. (2007). Stress et épuisement professionnel: Les techniques du stress. *Médecine thérapeutique*, 13(5), 297-305.
- Marchand, A., Juster, R. P., Durand, P., & Lupien, S. J. (2014). Workplace stressors and symptoms of psychopathology: The mediating role of cortisol. *Journal of psychosomatic research*, 76(6), 454-461.
- .
- Sarris, J., Panossian, A., Schweitzer, I., Stough, C., & Scholey, A. (2011). Herbal medicine for depression, anxiety, and insomnia: a review of psychopharmacology and clinical evidence. *European neuropsychopharmacology*, 21(12), 841-860.
- Lopresti, A. L., Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2014). Efficacy of a standardised extract of *Matricaria chamomilla* (Chamomile) in sleep onset insomnia and stress-induced insomnia: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Phytomedicine*, 21(8-9), 847-851.
- Pittler, M. H., & Ernst, E. (2003). Valerian for insomnia: a systematic review of randomized clinical trials. *Sleep medicine*, 4(3), 227-231.

- Mao, J. J., Li, Q. S., Soeller, I., Xie, S. X., & Amsterdam, J. D. (2016). Rhodiola rosea therapy for major depressive disorder: a study protocol for a randomized, doubleblind, placebo- controlled trial. *Journal of Clinical Trials*, 6(5), 1000297.
- Savage, K., Firth, J., Stough, C., & Sarris, J. (2018). GABA-modulating phytomedicines for anxiety: A systematic review of preclinical and clinical evidence. *Phytotherapy Research*, 32(1), 3-18.
- Panossian, A., & Wagner, H. (2005). Adaptogens: a review of their history, biological activity, and clinical benefits. *HerbalGram*, 67, 40-52.
- Kaur, R., Kaur, S., & Sharma, S. (2020). Withania somnifera as a potential anxiolytic and immunomodulatory agent in acute stress. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 131, 110734.
- Lemoine, P., Taillard, J., & Guilleminault, C. (2000). Herbal and dietary supplements for treatment of insomnia: efficacy and safety. *Journal of psychiatric research*, 34(5), 393-398.
- Bourin, M., Bougerol, T., Guitton, B., & Broutin, E. (2001). A combination of plant extracts in the treatment of outpatients with adjustment disorder with anxious mood: controlled study vs placebo. *Fundamental & clinical pharmacology*, 15(5), 293-297.
- Dimpfel, W., Koch, K., Weiss, G., & Wacker, R. (2018). Psychotropic effects of Silexan on the EEG in healthy volunteers and patients with anxiety disorders. *Pharmacopsychiatry*, 51(02), 73-81.
- Andreatini, R., Sartori, V. A., Seabra, M. L. V., & Leite, J. R. (2002). Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebocontrolled pilot study. *Phytotherapy research*, 16(7), 650-654.
- Bent, S., Padula, A., Moore, D., Patterson, M., & Mehling, W. (2006). Valerian for sleep: a systematic review and meta-analysis. *The American journal of medicine*, 119(12), 1005-1012.
- Paris, A., Gonnet, N., Chaussard, C., Belin, C., Bousquet, P. J., Dumas, M., ... & Durrieu, G. (2010). Treatment of stress symptoms in outpatient healthcare professionals: a randomized controlled trial of cognitive behavior therapy versus enhanced usual care. *Psychological medicine*, 40(01), 147-157.
- SOURCES MAGNESIUM : Walker et al., *Magnesium Research*, 2003. Tejero J. et al., *Cellular Metabolism*, 2020. Zhang et al., *Experimental and Clinical Cardiology*, 2004. Fine et al., *American Journal of Clinical Nutrition*, 1991.

MERCI !!

À VOUS, POUR VOTRE ÉCOUTE

ET À L'ESN POUR SA CONFIANCE 😊